

1. Introducción y relevancia en Salud Pública y en el EUNACOM

Chile es uno de los países más expuestos a desastres naturales en el mundo debido a su geografía y actividad sísmica: terremotos, tsunamis, erupciones volcánicas, inundaciones, incendios y, en los últimos años, emergencias sanitarias como la **pandemia por COVID-19**.

En este contexto, la **gestión de emergencias sanitarias** busca reducir el impacto de eventos adversos sobre la salud de la población mediante **planes preventivos, coordinados y multisectoriales**.

El médico general debe comprender la estructura, fases y componentes de un **plan de emergencia sanitaria**, así como su rol en la **respuesta, vigilancia y recuperación**, especialmente en la Atención Primaria de Salud (APS).

En el **EUNACOM**, este tema integra conocimientos de **epidemiología, salud pública, gestión sanitaria y liderazgo clínico**, siendo esencial para el trabajo en red y en contextos de crisis.

2. Conceptos fundamentales y marco conceptual

2.1. Emergencia sanitaria

Situación que afecta la salud colectiva y requiere acciones urgentes y coordinadas del sistema de salud para prevenir morbilidad, mortalidad y colapso asistencial.

Ejemplos:

- Epidemias y pandemias (COVID-19, influenza, dengue).
 - Brotes alimentarios o zoonóticos.
 - Catástrofes naturales con impacto sanitario (terremotos, incendios).
 - Crisis ambientales o químicas (contaminación, derrames).
-

2.2. Desastre

Evento súbito que **supera la capacidad de respuesta local o regional**, requiriendo apoyo externo.

Ley N° 21.364 (2021): define el *desastre* como una alteración intensa en el funcionamiento de la comunidad que causa pérdidas humanas, materiales y ambientales, y que requiere medidas extraordinarias.

2.3. Gestión del riesgo de desastres (GRD)

Conjunto de políticas, estrategias y acciones para **reducir vulnerabilidades y fortalecer capacidades**.

Basada en el **Marco de Sendai (ONU, 2015–2030)** y adaptada en Chile por el **SINAPRED** (*Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres*).

Componentes esenciales:

1. **Prevención:** reducción del riesgo.
 2. **Preparación:** planificación y simulación.
 3. **Respuesta:** manejo del evento.
 4. **Recuperación:** restablecimiento de servicios y rehabilitación.
-

2.4. Plan de emergencia sanitaria

Instrumento técnico-operativo que define **protocolos, responsabilidades y recursos** para actuar ante una emergencia que afecte la salud pública.

Objetivo general: garantizar la **continuidad asistencial** y proteger la salud de la población en condiciones de crisis.

3. Marco normativo chileno

Norma / institución	Contenido
---------------------	-----------

Ley N° 21.364 (2021)	Crea el Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SINAPRED).
Decreto Supremo N° 38/2022 (MINSAL)	Establece el <i>Plan Nacional de Emergencias y Desastres en Salud 2022–2030</i> .
ONEMI → SENAPRED (2022)	Coordina la respuesta nacional ante desastres.
Plan Nacional de Protección Civil	Define roles intersectoriales.
Manual Operativo de Emergencias MINSAL (2021)	Orienta la planificación de emergencias en hospitales y APS.

4. Componentes de un Plan de Emergencia Sanitaria

4.1. Análisis de riesgo

- **Identificación de amenazas:** biológicas, químicas, radiológicas, naturales o sociales.
- **Evaluación de vulnerabilidad:** infraestructura, población y recursos.
- **Capacidades locales:** servicios de salud, logística, redes de apoyo.

4.2. Preparación y organización

Incluye la **creación de comités locales de emergencia sanitaria** y la **capacitación del personal**.

Debe existir un **responsable institucional** y un **plan escrito y actualizado**, revisado al menos una vez al año.

4.3. Respuesta sanitaria

Acciones inmediatas ante la emergencia:

1. Activación del plan.
2. Comunicación y coordinación intersectorial (MINSAL, SENAPRED, municipios).
3. Triangulación de información epidemiológica.
4. Asignación de recursos humanos y materiales.
5. Continuidad de los servicios críticos (urgencias, vacunación, diálisis, parto).

4.4. Recuperación

- Rehabilitación física y mental de las víctimas.
- Evaluación de daños y aprendizajes post evento.
- Reconstrucción de infraestructura y reabastecimiento.
- Ajuste del plan institucional según evaluación posterior.

5. Estructura del Plan Nacional de Emergencias Sanitarias (MINSAL 2022–2030)

Eje estratégico	Descripción	Ejemplo
Gestión del riesgo en salud	Fortalece vigilancia y preparación en APS.	Simulacros de brotes infecciosos.
Respuesta sanitaria	Protocolos coordinados entre niveles asistenciales.	Activación de Hospital de Campaña.
Recuperación resiliente	Reconstrucción con enfoque psicosocial y equidad.	Apoyo post-terremoto.

Formación y cultura preventiva	Capacitación continua del personal.	Curso MINSAL de primeros respondedores.
Coordinación intersectorial	Articulación con SENAPRED, Defensa y Educación.	Plan comunal de emergencia sanitaria.

6. Fases del manejo de emergencias sanitarias

Fase 1. Prevención y mitigación

- Identificar riesgos locales (sísmicos, epidemiológicos).
- Mantener vacunación y control sanitario.
- Evaluar vulnerabilidad de servicios críticos.

Fase 2. Preparación

- Elaborar y actualizar el plan institucional.
- Capacitar equipos de salud y comunidad.
- Definir rutas de evacuación y puntos seguros.
- Realizar simulacros periódicos.

Fase 3. Respuesta

- Activar comités operativos de emergencia.
- Coordinar con SEREMI y SENAPRED.
- Priorizar atención de urgencia y apoyo psicosocial.
- Vigilar brotes, lesiones y fallecimientos.

Fase 4. Recuperación

- Restablecer infraestructura y servicios básicos.
- Evaluar daño sanitario y psicosocial.
- Documentar lecciones aprendidas.

7. Rol del médico general en emergencias sanitarias

Rol	Descripción	Ejemplo
Vigilancia y detección temprana	Identifica brotes o aumentos de casos inusuales.	Notificación inmediata al sistema EPIVIGILA.
Liderazgo local en APS	Coordina equipo en situaciones críticas.	Organización del Centro de Salud durante un sismo.
Educación comunitaria	Promueve medidas de autocuidado y prevención.	Charlas sobre higiene y manejo de agua en albergues.
Atención de urgencia y triage	Clasifica pacientes según prioridad vital.	Aplicación de protocolo START.
Salud mental postdesastre	Apoya contención emocional y derivación oportuna.	Atención grupal en comunidades afectadas.
Registro y comunicación	Documenta acciones y coordina con el nivel superior.	Reporte diario al Servicio de Salud.

8. Coordinación intersectorial

El éxito de los planes depende de la **colaboración entre múltiples actores**:

- **MINSAL y Servicios de Salud:** liderazgo sanitario y coordinación.
 - **SEREMI de Salud:** vigilancia epidemiológica y control ambiental.
 - **SENAPRED (ex ONEMI):** coordinación general del país.
 - **Municipios:** gestión local, albergues y ayuda social.
 - **FF.AA. y Carabineros:** apoyo logístico y de seguridad.
 - **Educación, Obras Públicas y Medio Ambiente:** apoyo intersectorial.
 - **Sociedad civil:** voluntariado y redes comunitarias.
-

9. Comunicación de riesgo

Pilar esencial para mantener la confianza de la población.

Debe ser **transparente, oportuna y coherente** con las autoridades sanitarias.

Principios OMS (2020):

1. Informar con rapidez y evidencia.
2. Usar lenguaje claro y empático.
3. Evitar rumores y desinformación.
4. Promover participación comunitaria.

Ejemplo: campañas durante COVID-19 sobre uso de mascarillas, testeo y vacunación.

10. Evaluación y mejora continua

- Evaluación **post evento (After Action Review)**: identifica fortalezas y brechas.
 - Incorporación de aprendizajes al nuevo plan.
 - Supervisión anual obligatoria según normativa MINSAL.
-

11. Errores comunes en EUNACOM

Error frecuente	Corrección conceptual
Pensar que la gestión de emergencias es solo tarea del hospital.	La APS es el eje de prevención, preparación y respuesta inicial.
Confundir emergencia con desastre.	El desastre ocurre cuando se supera la capacidad de respuesta local .
No considerar comunicación de riesgo.	La información a la población es parte del plan.
No registrar acciones durante el evento.	Toda respuesta debe documentarse.
Ignorar coordinación intersectorial.	El plan sanitario depende del trabajo con SENAPRED y municipios.

12. Complicaciones y desafíos actuales

1. **Cambio climático:** aumento de incendios, olas de calor, sequías e inundaciones.
2. **Emergencias biológicas globales:** nuevas pandemias y zoonosis.
3. **Vulnerabilidad de infraestructura sanitaria.**
4. **Desigualdad territorial:** zonas rurales con baja capacidad de respuesta.
5. **Desinformación digital:** riesgo para la comunicación sanitaria eficaz.

Desafío clave: fortalecer la **resiliencia sanitaria**, entendida como la capacidad del sistema para resistir, adaptarse y recuperarse frente a crisis.

13. Referencias ministeriales y técnicas

- MINSAL (2022). Plan Nacional de Emergencias y Desastres en Salud 2022–2030.
 - Ley N° 21.364 (2021). Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SINAPRED).
 - OPS/OMS (2015–2030). Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres.
 - SENAPRED (2023). Manual de Gestión del Riesgo de Desastres en Salud.
 - MINSAL (2021). Manual Operativo para Servicios de Salud y APS.
-

14. Resumen final — 5–7 ideas clave

1. Un **plan de emergencia sanitaria** define los protocolos para responder ante eventos que amenacen la salud pública.
2. La **Ley N° 21.364** y el **SINAPRED** establecen el marco legal y coordinativo nacional.
3. Las fases del plan incluyen **prevención, preparación, respuesta y recuperación**.
4. El **médico general** cumple un rol clave en la detección temprana, liderazgo local y educación comunitaria.
5. La **comunicación de riesgo** y la **coordinación intersectorial** son esenciales para una respuesta eficaz.
6. La **evaluación post evento** y la mejora continua fortalecen la resiliencia sanitaria.
7. En el EUNACOM, el enfoque debe ser integral: epidemiológico, ético, operativo y comunitario.